

20代から60代まで、すべての女性へ

女性の薄毛は、 なぜ起こる？ なぜ治りにくい？

原因・しくみ・治療の現実を、やさしく解説します



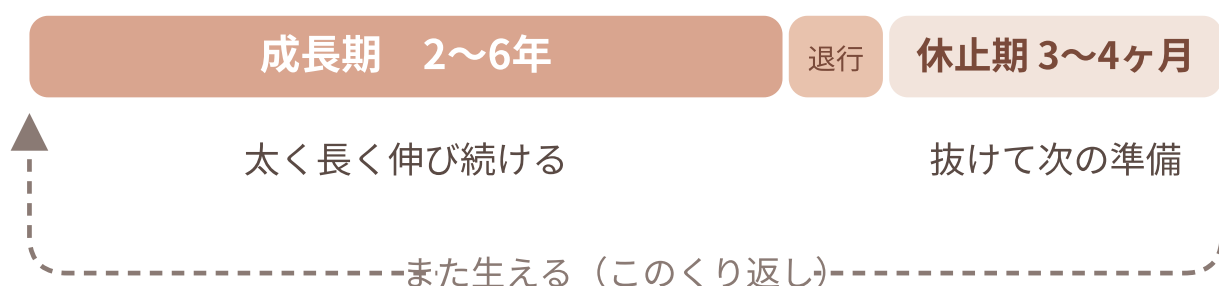
看護師 Kai（AGA・FAGA治療 施術5,000件超）がまとめました。

難しい言葉はなるべく使いません。

髪には「寿命のサイクル」があります

1本の髪は、生えて → 伸びて → 抜けて → また生える、を繰り返しています。

このサイクルが乱れることが、薄毛の正体です。^[1]



薄毛のとき、頭皮では何が起きている？

① 成長期が短くなる

本来2～6年伸びるはずの髪が、1年ほどで抜けてしまう。伸びきる前に抜けるので、短い毛が増えます。

② 毛が細くなる（ミニチュア化）

毛穴は残っているのに、そこから生える毛が産毛のように細く・色も薄くなる。本数はさほど減っていないくても「透けて見える」原因です。

だから女性の薄毛は、男性のように「ツルツルになる」ことはまずありません。頭頂部や分け目を中心に、全体がまばらに・細くなって地肌が透けて見えるのが特徴です。^{[1][2]}

原因はひとつではありません

更年期世代の薄毛は、いくつかの要因が重なって起こります。

① 女性ホルモンの減少

更年期に「エストロゲン」が減ると、髪ハリ・コシを保つ力が弱まります。相対的に男性ホルモンの影響が強まり、毛が細くなっていきます。閉経前後の数々が、抜け毛を実感しやすい時期です。^{[1][2][3]}

② 体質・年齢

ご家族に薄毛の方がいると、毛穴がホルモンの影響を受けやすい体質を受け継いでいることがあります。加えて年齢とともに髪をつくる力そのものがゆっくり落ちていきます。

③ からだの状態

鉄不足（貧血）、甲状腺の病気、急なダイエット、大きなストレス、出産後、強い薬の影響など。これらは治療で戻せることが多いので、血液検査で確かめる価値があります。

④ 髪への負担

きつく結ぶ髪型を長年続ける、頻繁なカラー・パーマ、強く擦る洗髪、紫外線。頭皮の炎症や引っ張りで、分け目や生え際が後退することがあります。

大切なこと：①②は「体質としてゆっくり進むもの」、③④は「取り除けるもの」。多くの方は両方が混ざっています。だからこそ「原因は何か」を分けて考えることが、遠回りしない一番の近道です。

若い世代の薄毛は、原因のパターンが違います

20～30代で「急に抜け毛が増えた」場合、多くは**体の変化やヘアケアが引き金**です。原因を取り除けば戻ることも多い世代です。^{[4][5]}

① 休止期脱毛（いっせいに抜ける）

過度なダイエット、鉄・亜鉛・たんぱく質の不足、出産後、大きなストレス、高熱の病気、薬の影響などで、多くの髪が同時に「休止期」に入り、**2～3ヶ月後にまとめて抜けます**。原因が去れば半年～1年で戻る人が多いタイプです。^{[4][5]}

② ホルモンの乱れ

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）、甲状腺の病気、ピルの服用や中止など。**若くして女性型脱毛症が進む場合は、ホルモン異常が隠れていることがある**ため、婦人科・内科での検査が大切です。^{[2][5]}

③ 髪を引っ張る・傷める

ポニーテール・お団子・編み込みなど同じ髪型を続けると、力のかかる生え際や分け目だけが薄くなります（牽引性脱毛）。頻繁なブリーチ・カラー・アイロンも髪と頭皮の負担になります。^{[5][6]}

④ 頭皮の状態

皮脂が多くベタつくフケ（脂漏性）、乾燥したパサパサのフケ（乾癬性）は、頭皮の炎症から抜け毛につながります。**丸く抜ける「円形脱毛症」は別の病気**で、早めに皮膚科へ。^[5]

年代別・まず疑う原因

年代	よくある原因	最初に相談する先
20代	ダイエット・栄養不足、ストレス、髪型・ブリーチ、PCOS、ピルの変更	皮膚科・婦人科
30代	出産後の抜け毛、育児疲れ・睡眠不足、鉄不足、甲状腺	皮膚科・内科
40～50代	更年期のホルモン変化＋体質（女性型脱毛症）、白髪染めの負担	皮膚科・薄毛専門
60代～	加齢による毛の細り、持病の薬、栄養の偏り	皮膚科・かかりつけ医

なぜ「治りにくい」と言われるのか

年代を問わず、女性の薄毛治療が男性より難しいのには、はっきりした理由があります。

1 使える薬が限られている

男性の薄毛治療の主役「フィナステリド」「デュタステリド」は、**女性には使ってはいけない**と学会ガイドラインに明記されています（推奨度D）。女性で科学的に効果が確かめられている薬は、塗り薬のミノキシジルがほぼ唯一です。

[1]

2 効果が出るまで半年以上かかる

髪のコイルは月単位で動くため、薬を始めても**変化を感じるのは4〜6ヶ月後**。最初の1〜2ヶ月は一時的に抜け毛が増えることもあり、ここで諦めてしまう方が多いのです。

3 目標は「増やす」より「守る」

治療で期待できるのは、主に**細くなった毛を太く戻す・進行を遅らせる**こと。20代の髪に戻ることは現実的ではなく、「これ以上減らさない」が第一目標になります。

4 やめると戻る

薬は「使っている間」効くもの。中止すると数ヶ月で元の状態に戻っていきます。**長く続けられるかどうか**が、費用・手間の両面で現実的な壁になります。

5 全体がまばらだから、植毛も向きにくい

植毛は「後頭部の元気な毛」を移す手術。女性は後頭部も含めて全体が薄くなる方が多く、移せる毛が足りないことがあります。ガイドラインでも女性の植毛は「考慮してもよい」程度（推奨度C1）にとどまります。[1]

女性に対して、何がどれくらい効くのか

日本皮膚科学会のガイドライン（2017年版）は、治療法ごとに「おすすめ度」を決めています。^[1]

治療法	女性へのおすすめ度	ひとこと
ミノキシジル（塗り薬・1%）	A 強くすすめる	女性で唯一の「A」。市販もあり。半年は続ける
LED・低出力レーザー	B おすすめ	家庭用機器も。効果はゆるやか
アデノシン等の育毛剤	C1 考慮してもよい	根拠は限定的。補助的に
自毛植毛	C1 考慮してもよい	後頭部の毛量があれば選択肢に
フィナステリド／デュタステリド（飲み薬）	D 行うべきでない	男性の主力薬。女性には不可

※スピロノラクトン内服など、一部のクリニックで用いられる女性向け内服薬は、ガイドラインでの評価対象外または根拠不十分の扱いです。使う場合は医師の説明をよく聞いてください。

まずやってほしいこと

- ☐ 皮膚科または薄毛専門クリニックで「原因の切り分け」をしてもらう
（血液検査で鉄・甲状腺・ホルモンを確認）
- ☐ 治すべき原因（鉄不足・甲状腺など）があれば、そこから治す
- ☐ 体質による薄毛なら、ミノキシジル塗布を半年以上続けて「守る」

「守る治療」と「今日の見た目」は、別々に考えられます

薄毛治療は時間がかかり、増やせる量にも限りがあります。だからこそ、**治療で髪を守りながら、見た目は別の方法で整える**という考え方があります。

治療（医師）

半年～年単位

細くなった毛を太く戻す
これ以上減らさないように守る

頭皮アートメイク（Kai）

施術した当日から

地肌の透けを目立たなくする
髪は増えないが、増えたように見える

なぜ相性がいいのか

- 治療の「効果が出るまでの半年」を、見た目のストレスなく待てる
- アートメイクは治療薬（塗り薬・飲み薬）の妨げになりません。塗り薬は施術後1週間お休みするだけ
- 「増やせる量に限りがある」女性の薄毛でも、透けを埋めることで密度感が出る

「私の薄毛はどのタイプ？」から、一緒に整理します

ご相談・ご予約は公式LINEから ／ Instagram：@smp___kai

出典

- [1] 日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」日本皮膚科学会雑誌 127巻13号 p.2763-2777（2017）
https://www.dermatol.or.jp/dermatol/wp-content/uploads/xoops/files/AGA_GL2017.pdf
- [2] メディカルノート「女性型脱毛症」（2020） <https://medicalnote.jp/diseases/女性型脱毛症>
- [3] 有澄クリニック「更年期の薄毛は治る？」（2026） <https://arizumi-clinic.com/media/menopause-thinning/>
- [4] みんなの家庭の医学WEB版「20代女性の抜け毛」（保健同人社、2022） <https://kateinoigaku.jp/qa/2588>
- [5] 神戸きしだクリニック「20代から始まる女性の薄毛悩み」（2026） <https://kobe-kishida-clinic.com/faga/women-cause/young-faga/female-hair-loss-twenties-causes-selfcare/>
- [6] FITクリニック「20代女性の薄毛 原因・症状・対策」（2026） https://fit.clinic/symptoms/faga/hairloss_20s/
- 推奨度A=行うよう強く勧める／B=行うよう勧める／C1=行ってもよい／D=行うべきではない（[1]の分類）。個々の診断・治療は必ず医師にご相談ください。